Coût direct des infections respiratoires aigües sévères des enfants de moins de cinq ans à la charge des ménages dans les CHU CDG et YO à Ouagadougou

Nom du présentateur : Belemsaga/Yugbaré D.

Auteurs et coauteurs : Wandaogo S.C.; Cisse K., Dahourou D. L., Ouédraogo H.G. et Kouanda S.

Affiliations : Institut de Recherche en sciences de la santé (IRSS)

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Infections respiratoires aigues (IRA) : problème de santé publique

  ➡ lourde charge pour système de soins de santé

- Une des principales causes de décès chez les -5 ans monde/pays ressources limitées (Sinha A.; 2012)

- 20 à 60% des consultations externes chez les enfants(Stansfield S.K. ;1991, Nair H.; 2013)

- 12 à 45% des hospitalisation (OMS 2010)

- Burkina Faso: PEC gratuite des soins chez les moins de 5 ans

Introduction

- Obstacle de la gratuité des soins: rupture fréquente des consommables avec contribution des ménages/ statut socioéconomique bas en Afrique

- Etudes sur les coûts de la PEC des IRA :

✓anciennes et insuffisantes

✓principalement en Europe et Amérique

- Etudes en Afrique: aspects épidémiologiques, cliniques et virologiques ➡ méritent d'être complétées

Objectif

❑**Général** Evaluer le coût moyen direct de la prise en charge des IRAS supporté par les ménages chez les enfants – 5 ans aux CHUN-YO et CHUP-CDG; et identifier ses facteurs associés.

❑**Spécifiques**

✓Evaluer le coût médical direct moyen supporté par le ménage dans la PEC des IRAS des enfants hospitalisés.

✓Estimer le coût non médical direct moyen de ces IRAS

✓Identifier les facteurs qui influencent le coût moyen direct de PEC

Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude :** CHUP-CDG et CHUN-YO
- **Type d'étude:** cohorte prospective ouverte
- **Période d'étude:** 20 août au 14 décembre 2020
- **Population d'étude: e**nfants de 0 à 5 ans hospitalisés pour IRAS.
  - ✓**Critères d'inclusion**: enfants de moins de 5ans hospitalisés pour IRAS.
  - ✓**Non inclusion**: pathologies aigues associées et/ ou comorbidités, durée <21 jours
- **Collecte et analyse des données**
  - ✓Entretien auprès des parents/consultation des dossiers médicaux
  - ✓Analyse bivariée et multivariée à l'aide de Stata 14
- **Approbation du comité d'éthique** (délibération 2020-8-163)

Matériel et méthode(s)

❑**Variable dépendante: Coût total direct moyen (dtm)**

✓**Coût direct médical moyen :** frais de consultation, dépenses liées aux médicaments et examens complémentaires ;

✓**Coût direct non médical moyen** : frais de transport non sanitaire, frais d'hébergement, dépenses de restauration, autres dépenses (frais d'utilisation des toilettes, dépenses pour couches et autres équipements...)

Résultats

❑Caractéristiques socio-démographiques

✓248 Nourrissons de 1 à 36 mois : IRAH 21% et IRAB 49%

✓Enfants malnutris: IRAH 2% et IRAB 7%

✓Patients vivant en zone rurale: IRAH 35% et IRAB 44%

✓Mères de -20 ans: 18% Mères sans emploi: 58% ; Secteur informel 30%

✓Pères du secteur informel: 54%

✓Durée moyenne de séjour : 7 jours avec un écart type de 0.17.

Résultats

❑**Tableau I: Coût direct médical moyen (en FCFA)**

Variables	Coûts moyens [IC 95%]	Minimal	Maximal
Coût des médicaments	10 800,7 [9 514,8 12 086,6]	0	60 000
Coût des examens complémentaires	838,10 [381,97 1 294,24]	0	27 300
Coût médical direct moyen	**11 639** [10 310 12 967.6]	0	60 000

❑**Coût médical moyen direct élevé** (contexte de gratuité des soins)

Résultats

❑Tableau II: Coût direct non médical moyen (en FCFA)

Variables	Coûts moyens [IC 95%]	Minimal	Maximal
Frais de référence	358,87 [199,499 518,2429]	0	10 000
Frais d'hébergement	2 441,94 [1163,276 3 720,595]	0	101 000
Frais de nourriture	13 594,15 [11 984,49 15 203,82]	0	88 000
Frais de transport	7 508,87 [6 235,614 8 782,128]	0	10 540
Autres dépenses	1 232,26 [883,7745 1 580,742]	0	16 800
Coût non médical direct moyen	**25 136** [22 176.28 28 095.9]	0	178 000

❑**Coût non médical direct PEC par le ménage** : 25 136 FCFA (68% du dtm)

Raisons: Insuffisance de l'Etat dans la PEC des frais d'hébergement

Résultats

❑Tableau III: Coût total direct moyen (dtm) (en FCFA)

Variables	Coûts moyens [IC 95%]	Minimal	Maximal
Coût total médical moyen	11 639 [10 310 12 967.6]	0	60 000
Coût total non médical moyen	25 136 [22 176.28 28 095.9]	0	178 000
Coût total direct moyen	**36 775** [33 165.63 40 384.15]	0	211 500

Résultats Tableau IV: Facteurs associés au sqrt_dtm

Sqrt_dtm	Coef.	P>|t|	[95% Conf	Interval]
Durée de séjour hospitalier	15,281	**0**	13,131	17,43034
Type d'IRAS	4,383	0,539	-9,6488	18,41447
PEC des frais de référence				
Oui	33,617	0,001	14,619	52,61611
Profession de la mère				
Salarié du privé	-28,382	0,211	-72,971	16,20645
Secteur informel	-37,593	**0,015**	-67,771	-7,414524
Sans emploi	-36,196	**0,016**	-65,464	-6,927547
Profession du père				
Salarié du privé	-1,907	0,87	-24,843	21,02775
Secteur informel	-12,885	0,239	-34,389	8,619141
Sans emploi	-40,822	**0,024**	-76,158	-5,485663
Type de payeur				
Tiers payeur	-71,853	**0,004**	-120,54	-23,16346
Constante	89,446	0,005	27,601	151,2917

Conclusion

- Dépense totale moyenne des ménages pour IRA : 36 775 FCFA(IC 95%: 33 165.63 40 384.15); Augmentation de ce coût/ durée de séjour hospitalier
- Facteurs associés durée de séjour, PEC des frais de référence, profession du père et de la mère, type de payeur
- Insuffisance dans l'offre des services de la gratuité.
- Améliorer la disponibilité des médicaments en milieu hospitalier et l'utilisation rationnelle des médicaments
- Evoluer vers la couverture sanitaire universelle.

Merci pour votre attention

belemsagadanielle@yahoo.fr